

表 8 VA-ECMO 临床启动快速筛查评估表(1)

姓名			性别	☐ 男 ☐ 女	
住院号			评估时间	20__年__月__日 __时__分	
启动场景	☐ 普通 VA ☐ ECPR(心跳骤停) ☐ 术中/术后脱机困难		年龄	岁	
第一步：绝对禁忌筛查(任何一项勾选"是"→ 通常不建议启动 VA-ECMO)					
筛查项目				是	否
存在致命性且不可逆原发疾病，或预期寿命极差(如终末期恶性肿瘤、慢性器官衰竭终末期等)				☐	☐
心脏功能基本无恢复可能，且无心脏移植或长期 LVAD 指征				☐	☐
人工机械主动脉瓣（外周 VA-ECMO 时瓣叶不开放→瓣膜血栓风险极高）				☐	☐
严重不可逆神经系统损伤(如脑死亡、全脑缺氧严重脑损伤、广泛脑创伤或大面积脑出血)				☐	☐
急性 A 型主动脉夹层（术前）/B 型夹层伴广泛分支受累				☐	☐
严重的、无法控制的活动性出血或不可逆的凝血功能障碍				☐	☐
有任何"是"→停止评估,VA-ECMO 不适合。ECPR 需 2 分钟内做出判断，无绝对禁忌→立即启动,不延迟。					
第二步：难治性心源性休克指标评估[已给予最佳药物治疗(容量优化+血管活性药+正性肌力药)仍无改善]					
2.1 起效时间判断（不需一律等 6 小时）					
病因		最短观察时间	说明		
暴发性心肌炎/心脏术后脱机困难/药物中毒/大面积 PE		2-3 小时	病情可急剧恶化，不宜久等		
AMI 心源性休克/终末期心肌病急性失代偿		3-6 小时	需确认对药物+IABP 无效		
ECPR（心跳骤停）		不适用此标准	见(表 12-14),CPR≥15 min 未 ROSC 即可启动		
2.2 组织灌注不足指标（满足 ≥ 3 项）					
指标	异常标准		当前值		
收缩压	SBP<90mmHg，或需大剂量血管活性药维持		SBP____ / 去甲____ μg/kg/min		
心脏指数（如有 PAC）	CI <2.0 L/min/m ²		____ L/min/m ²		
超声 LVEF	LVEF < 20-25%或 LVOT VTI < 10 cm		LVEF____ % / VTI____ cm		
血管活性药剂量	去甲>0.3μg/kg/min+多巴酚丁胺>10 μg/kg/min,仍无效		去甲____ 多巴酚丁胺____		
尿量	< 30mL/h（或<0.5 mL/kg/h）		____ mL/h		
乳酸	> 2.0mmol/L 且持续不降或上升		____ mmol/L		
ScvO ₂ / SvO ₂	<60%		____ %		
意识状态	改变（精神萎靡/谵妄/昏迷）		☐ 有 ☐ 无		
第三步：病因/适应症勾选(核心适应症)					
病因		病因			
急性心肌梗死导致的心源性休克		心脏直视术后（含心脏移植/LVAD 术后）急性心源性休克/脱机困难			
暴发性心肌炎		重度药物/毒物中毒导致的心脏毒性或心功能抑制			
大面积肺栓塞伴循环不稳定					
第三步：病因/适应症勾选(扩展与新型适应症)					
病因		病因			
ECPR:难治性心脏骤停,常规 CPR≥15-20min 未 ROSC		高危 PCI/CABG 术中后备支持			
重度恶性心律失常（电风暴）致难治性循环不稳定		脓毒症相关心肌病			
严重低体（<30□）伴循环不稳定		产后急性心肌病			

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIJ)+SAVE 评分(Schmidt et al.2015)+ECPR 相关指南(AHA

2025) 用途: VA-ECMO 启动前的快速四步评估, 5-10 分钟内完成
配套使用: 表 15 (SAVE 评分) + 表 12-14 (ECPR 专项流程)